

Cas pratique-Covid long

Sommaire :

1. Définition d'un Covid long
2. Les symptômes
3. État des lieux
4. Les pistes scientifiques
5. Cas pratique : François
6. Conclusion

I-Définition d'un Covid long :

- Définition :

OMS :

« « COVID long », est décrit sous la dénomination d'« affection post-COVID-19 » par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et apparaît généralement dans les 3 mois suivant l'infection initiale au SARS-CoV-2. »

Assurance maladie :

« Le Covid-19 est une maladie dont les signes disparaissent dans la plupart des cas en 2 à 3 semaines. Toutefois, certains malades peuvent encore ressentir des symptômes au-delà de 4 semaines après l'infection. On parle de symptômes prolongés du Covid ou de Covid long. »

« Ces « **symptômes prolongés suite au Covid-19** » ne peuvent pas être expliqués par une autre maladie sans lien connu avec le Covid-19. »

II-Les symptômes :

- Les symptômes :

La fatigue :

- La fatigue est le symptôme le plus fréquent

Des symptômes respiratoires :

- Un essoufflement sans effort ou pour des efforts peu importants et la persistance d'une toux sont fréquents.

Des douleurs multiples :

- Douleurs thoraciques
- Céphalées
- Douleurs des oreilles avec ou sans acouphènes

- Sensation de brûlures de la peau ;
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Maux de ventre (brûlures et crampes de l'estomac, douleurs de l'intestin)

Des problèmes de peau :

- Prurit cutané, urticaire
- Pseudo-engelures aux pieds ou aux mains
- Chute de cheveux

Des problèmes oculaires :

- Larmolement, des yeux rouges ou une sensation de sable sous les paupières avec des démangeaisons des yeux
- Une fatigue oculaire
- Des troubles de la vision (baisse de l'acuité visuelle, vue double, images anormales)...

Des troubles digestifs :

- Bouche sèche
- Régurgitations
- Douleurs lors de la déglutition ou douleurs abdominales, ballonnements abdominaux et dyspepsie
- Nausées, constipation, diarrhée
- Intolérance à certains aliments
- Baisse ou perte d'appétit, avec ou sans amaigrissement.

Des anomalies des sens post Covid :

- Des troubles de l'odorat ou du goût persistent après l'épisode aigu de Covid.

Des troubles psychologiques :

- Les troubles anxieux sont le plus souvent des troubles anxieux généralisés et moins fréquemment des troubles paniques
- La dépression se traduit par de la tristesse, une perte d'intérêt et de plaisir, des troubles de l'attention et de la mémoire
- Certaines personnes ayant été hospitalisées en soins intensifs ou en réanimation présentent un syndrome de stress post-traumatique persistant plus d'un mois après l'évènement traumatisant

Des troubles multiples :

- Des difficultés de concentration et de mémoire
- Une mauvaise qualité du sommeil avec apparition d'insomnies notamment, de micro-réveils, d'un sommeil perçu comme non réparateur, d'une hypersomnie dans la journée
- Des sueurs froides ou chaudes, de la fièvre avec éventuellement des frissons
- Des fuites urinaires
- Un dérèglement menstruel (règles espacées anormalement)
- Des troubles de l'érection et une diminution de la libido...

III- État des lieux :

- Etat des lieux :

L'essentiel des résultats à retenir

- La prévalence de l'affection post-COVID-19 (définition OMS) est estimée à 4 % en population générale adulte (correspondant à 2,06 millions de personnes).
- 1,2 % des personnes interrogées déclarent un impact fort ou très fort sur leurs activités quotidiennes.
- 7,1% des participants ont déclaré avoir été atteints de COVID long lorsque qu'on leur posait la question (COVID long rapporté).
- Parmi les 48% de personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 depuis plus de trois mois, 8% présentaient les critères d'une affection post-COVID-19.
- La prévalence était plus élevée chez les femmes (10,2%), chez les personnes en recherche d'emploi (14,9%) et chez les sujets ayant été hospitalisés pour COVID-19 (18,6%).
- 21,3% des personnes rapportant une affection post-COVID-19 ont été infectés à l'occasion de la vague du variant Delta et 53,2% lors des vagues de variants Omicron.

Malgré la stabilisation de la prévalence fin 2022, la surveillance du COVID long et notamment de l'affection post-COVID-19 reste toujours fortement requise dans les mois à venir. Cette affection s'est en effet immédiatement imposée parmi les affections chroniques les plus fréquentes. En particulier, les formes prolongées (31% des cas) et celles dont les symptômes ont un impact fort ou très fort sur les activités quotidiennes (30%) représentent vraisemblablement une charge importante pour le système de soin.

Source : Santé Publique France – art « COVID long : 2 millions de personnes présentaient une affection post- COVID-19... 13

IV- Les pistes scientifiques : (Immunité, muqueuse intestinale, diagnostic)

- Les pistes scientifiques :

- L'hypothèse des chercheurs est que le SARS-CoV-2 pourrait se calfeutrer au niveau de la muqueuse intestinale car celle-ci est plus « permissive » sur le plan immunitaire que le reste de l'organisme, dans la mesure où elle doit tolérer la flore bactérienne.
- Réponse immunitaire innée dérégulée

- **L'auto-immunité** (l'infection par SRAS-CoV-2 déclencherait la production d'anticorps qui s'attaquent à l'organisme du patient)
- La **réactivation de virus dormants** (autres que le coronavirus)
- Un **déséquilibre du microbiote** (dysbiose)

Source : <https://presse.inserm.fr/covid-long-la-persistance-du-sars-cov-2-dans-les-muqueuses-pourrait-etre-en-cause/66958/>

<https://presse.inserm.fr/covid-long-lhypothese-dune-reponse-immunitaire-deregulee-pour-expliquer-la-persistance-des-symptomes/65829/>

- Il est possible que **la ou les causes du Covid long soient similaires chez tous les patients**, mais que la maladie s'exprime différemment en fonction du terrain de chacun, des particularités de son système immunitaire, de facteurs hormonaux, de la sévérité des symptômes de l'infection initiale.
- **En conclusion** : le Covid long est associé à de nombreuses perturbations biologiques, en particulier des mécanismes de défense du corps contribuant à la persistance du virus à bas bruit chez certaines personnes, mais aussi à l'apparition d'un état immuno-inflammatoire chronique, impliqué dans l'apparition de divers symptômes.

Source : <https://www.sante.fr/quelles-sont-les-causes-du-covid-long>

V- Cas pratiques :

1- Première consultation - François - Janvier 2023

Cas pratique n° 1 : François

François, 50 ans, célibataire, un enfant de 15 ans, chef de projet informatique, 1m80, 79 kg.

- **Pratiques** : natation, footing, se déplace en vélo. Sport = nécessité = détente
- **Son motif** : « sensibilité digestive depuis toujours. Mais amplifié depuis le premier covid (2019) ».
- **Symptômes liés au motif** : diarrhées, crampes intestinales, ballonnements, gaz, ne digère plus les aliments gras et l'alcool.
- **Antécédents** : terrain anxieux depuis le Covid (prise de Xanax 3 mois). Urticaire généralisé (1 semaine).
- **Examens** : coloscopie = RAS
- **Rythme** : a vécu en Asie jusqu'en 2019. Travaille la semaine (9h-18h), fait beaucoup de sport. Soirée calme, 1 week-end sur 2 il voit son fils.

Traitements / compléments alimentaires :

- Citrate de bétaine = lui fait du bien
- Ne prend plus de Xanax

Excitants :

- **Alcool** : 1xS car provoque des douleurs digestives et des diarrhées
- **Tabac** = 1 cig/j
- **Boissons** = café (3/j)

Alimentation :

- **Manque de légumes**
- **Bon équilibre protéique** (œufs, poisson, volaille, viande rouge)
- Aime les **petits poissons gras** mais n'en mange pas
- **Féculents** : riz, pain, pâtes, lentilles
- **Lipides** : huile d'olive et de colza
- **Produits laitiers** : yaourts, fromages, mais ne boit pas de lait

Repas :

- **Petit dej** : 1 fruit + granola + yaourt ou 1 viennoiserie + café
- **Matinée** : boit 1 ou 2 cafés
- **Dej** : cantine = féculent + légumes + une protéine + fromage ou yaourt. Traiteurs = japonais ou asiatique
- **Ni goûter ni grignotage**
- **Dîner** = soupe de légumineuses, riz cantonnais (traiteur), salade composé, tartine de fromage, sushi
- **Ne boit pas assez d'eau**

Système digestif :

- Mange vite et mastique peu
- Ballonnements
- Selles = plusieurs fois par jour – rarement moulées
- Parfois des RGO
- Ne supporte pas

Sommeil :

- Dort bien 23h à 7h
- Se réveille fatigué

Système nerveux :

- Nervosité - hyperactivité
- Anxieux

2- Covid long et troubles digestifs

- Covid long et troubles digestifs :

Le tube digestif a sans doute un rôle important dans les symptômes prolongés de la Covid-19.

Environ 20 % des patients rapportent des symptômes digestifs lors de la phase prolongée de COVID.

Symptômes (ref fiche en annexe) :

- **Diarrhée chronique**, c'est le symptôme le plus fréquent (environ 6 à 10 % des patients).
- **RGO**
- **Une dyspepsie douloureuse** associant douleurs épigastriques rythmées par l'alimentation, satiété précoce, lenteur à la digestion, plénitude épigastrique
- **Des douleurs abdominales** isolées, parfois rythmées par l'alimentation, le plus souvent diffuses.

HAS • Les symptômes digestifs parmi les symptômes prolongés de la Covid-19 •

- Pourquoi ces patients présentent-ils des troubles digestifs ?

- Une **conséquence de l'anxiété et du stress** générés par l'épidémie et les périodes de confinement
- Une **dysautonomie** par atteinte de la 10ème paire crânienne (nerf vague ou pneumogastrique) avec une gastroparésie
- Une **infection virale digestive** persistante
- Des anomalies du microbiote ou **dysbiose**

HAS • Les symptômes digestifs parmi les symptômes prolongés de la Covid-19 • janvier 2023 – Mise à jour en janvier 2023

- Que peut-on proposer aux patients qui gardent des troubles digestifs prolongés ?

En l'absence de mécanisme physiopathologique identifié le traitement est essentiellement symptomatique en se basant sur les traitements habituels des syndromes fonctionnels digestifs.

La prise en charge des symptômes digestifs doit être progressive et s'intégrer dans **une prise en charge multidisciplinaire globale**.

- **En cas de diarrhée**, sans lésion identifiée, **ralentisseurs du transit** (loperamide) ou anti- sécrétoires (racécadotril), à dose adaptée.

- **En cas de douleurs : antispasmodiques** (phloroglucinol, alvéine, trimébutine, mébévérine...).

- Régime alimentaire :

- **Régime pauvre en FODMAPs** (Fructo- Oligo- Di- Monosaccharides And Polyols) a montré une efficacité. Il pourrait être proposé aux patients avec des symptômes prolongés de COVID signalant des intolérances alimentaires.
- Dans l'hypothèse d'une dysbiose persistante un traitement par **probiotiques** pourrait être envisagé.

→ **Lien Haute Autorité de Santé = fiche & accompagnement par symptômes**

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

3- Les conseils :

Alimentation, gestion du stress, hygiène de vie, compléments

- Les conseils pour François :

Conseils alimentaires :

- **Mastiquer**
- **Remplacer ses cafés** par du Yannah ou chicorée
- **Arrêter le gluten** (un temps pour observer sa digestion)
- **Prendre un petit déjeuner** protéique et lipidique
- **Hydratation** : 1,5 - 2 L/j
- **Légumes** = 50 % de l'assiette midi et soir
- **3 repas** par jour à heure fixe
- **Épargne digestive** avec des assiettes simples et digestes
- **Assiette du midi** : 50% légumes, 15 % de glucides complexes, 25 % de protéines, 10 % de bon gras
- **Assiette du soir** : légumes cuits et protéine maigre
- **Pas de fromage** le soir
- **Omégas 3** (DHA) : maquereaux / sardines
- **Féculents à IG bas** pour éviter les pics de glycémie
- **Diminuer les sucres cachés**
- **Tester les aliments probiotiques/prébiotiques** : kombucha, kéfir, miso, choucroute, légumes lacto- fermentés...

- **Tester les aliments riches en soufre** pour soutenir le foie et le pancréas : brocoli, choux de Bruxelles, choux, chou-fleur, ail et oignon
- **Aliments riches** en vit C, vit B, Mg et antioxydants
- **Des aliments riches en enzymes digestives** : les légumes, les fibres solubles (carotte, la patate douce et la courgette), les graines germées, les aliments fermentés : cornichons, olives, câpres.

Menus :

Petit-déjeuner (plusieurs propositions) :

- Pain sans gluten(sarrasin) + beurre(cru, encore mieux) + jambon
- Crêpe au sarrasin + jambon +/- fromage de chèvre ou brebis
- Œufs à la coque et mouillettes de beurre
- Avocado toast (avocat écrasé sur une tartine de pain au levain)

Déjeuner :

- **50% de légumes divers et variés**
- **25% de protéines animales** (œufs, poissons, viandes blanches, fruits de mer) ou **végétales** (tofu, légumineuses)
- **15% de glucides complexes** (pâtes complètes, riz complet, quinoa, sarrasin, patate douce...)
- **10% de bons gras** (avocat, maquereaux/sardines, huile de colza, huile olive, oléagineux...)

Dîner :

- Le soir, **légumes +++** (cuits plutôt à la vapeur), **protéines maigres** si vous avez mangé végétarien le midi (vous pouvez faire cuire des blancs de poulet et du poisson à la vapeur).
- **Eviter le gras le soir et les féculents.**
- Priorité **aux légumes et protéines maigres.**

Hygiène de vie :

- Poursuivre **ses activités sportives**
- Se coucher et se lever **à heure fixe**
- **Dîner avant 20h**
- Pratiquer **des exercices de respiration**
- Appliquer **une bouillotte chaude (max 60°) sur le foie**

Compléments :

L'argile verte montmorillonite et illite surfine

✓ 1 verre d'eau d'argile le matin à jeun – 2 semaines

Permearegul (Copmed) = L-glutamine, L-thréonine, La L-sérine, des polyphénols, du Boswellia serrata , NAC, fibres prébiotiques, Mélisse, Myrtille, Quercétine, Vit B, Vit A, Vit E.

Renforce la qualité du mucus intestinal en cas d'hyperperméabilité intestinale.

✓ 1 sachet/j – 3 mois – commencer après la cure d'argile

Magnésium (bisglycinate)

✓ 300 mg/J réparti sur la journée - 1 mois – à renouveler 38

4- Consultation de suivi - François - Avril 2023

- Suivi 1 François :

Ce que François a mis en place :

Alimentation :

- **Petit déjeuner** => œufs à la coque ou avocat + pain complet + thé vert
- **Déjeuner** => cantine avec un plus de légumes, une protéine et une portion de féculent (blanc), mais ne mange plus de pain. Pas de dessert, pas de fromage.
- **Dîner** => légumes vapeur et une portion de féculents sans gluten (riz, quinoa) car il fait du sport
- **Ses remarques** => il mange davantage de poissons, les huîtres lui font beaucoup de bien, il adore les graines germées. Il n'a pas arrêté l'alcool mais il supporte un peu mieux un verre de vin. Boit 1 café/j. Il ne boit pas assez d'eau. Doit faire des efforts pour mastiquer.

Comment va sa digestion ?

- Moins de diarrhée
- Selles = 1xj – si stress 2 à 3 fois – elles sont plus moulées
- Moins de prurit anal
- Mais sent encore sa digestion fragile
- Des crampes intestinales (2xs)
- « Il souhaiterait retrouver sa digestion d'avant covid »

Gestion du stress :

- Moins stressé, plus d'énergie
- A commencé un travail psy (lui fait beaucoup de bien)
- Difficile d'être assidu avec la cohérence cardiaque

Accompagnement spécifique :

- A pris **l'argile** => selles moulées et moins odorantes
- Prend **Permearégul** (lui reste encore 10 sachets quand on se voit)
- A terminé le **Magnésium**

Ce que je lui propose :

- **Soutenir ses enzymes digestives** => mettre l'accent sur les aliments riches en enzymes et en souffre
- **Eliminer le gluten** durant 2 mois pour voir si il y a une nette amélioration
- Inclure petit à petit des **aliments pré/probiotiques**
- **Mastiquer +++**
- A la fin de la cure **Permearegul**, renforcer la barrière intestinale **avec L-Glutamine, Zinc, L-Carnosine**
- Cure de **probiotiques**

→ François m'appelle 15 jours après notre consultation de suivi pour me dire **qu'à l'arrêt de Perméaregul les diarrhées sont revenues**

→ Je lui propose alors **d'en discuter avec son médecin (Covid long et troubles digestifs)** car je m'interroge sur la présence d'**Helicobacter Pylori** dans l'estomac, d'une **insuffisance enzymatique**, d'une **dysbiose**, d'une **hyperperméabilité intestinale**, d'une **parasitose** (prurit anal, crampes, nervosité...) => mais attention

le naturopathe ne fait pas de DIAGNOSTIC

→ Son médecin lui propose de faire une **sérologie NFS et marqueurs inflammatoires + HBP.**

→ Je lui parle d'un test de selle (non remboursé) pour avoir une idée plus précise de certains marqueurs digestifs : **HBP, dysbiose, parasites, intolérance au gluten, inflammation intestinale, enzymes...**

→ Il accepte de faire le test

→ En attendant les résultats, **arrêt total des compléments**

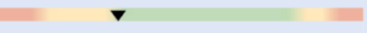
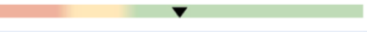
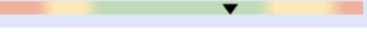
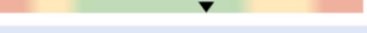
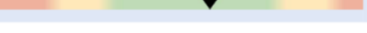
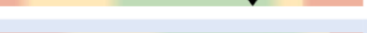
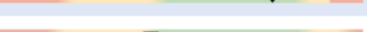
- Résultats GI MAP (test de selle) : (HBP, dysbiose, parasites, champignons, marqueurs digestifs...)

HELICOBACTER PYLORI

H. PYLORI & VIRULENCE FACTORS

	Result	Reference
<i>Helicobacter pylori</i>	1.93e2	< 1.00e3
Virulence Factor, babA	N/A	Negative
Virulence Factor, cagA	N/A	Negative
Virulence Factor, dupA	N/A	Negative
Virulence Factor, iceA	N/A	Negative
Virulence Factor, oipA	N/A	Negative
Virulence Factor, vacA	N/A	Negative
Virulence Factor, virB	N/A	Negative
Virulence Factor, virD	N/A	Negative

COMMENSAL/KEystone BACTERIA

COMMENSAL BACTERIA	Result	Reference
<i>Bacteroides fragilis</i>	6.16e9 	1.6e9 - 2.5e11
<i>Bifidobacterium</i> spp.	6.80e9 	> 6.7e7
<i>Enterococcus</i> spp.	1.58e7 	1.9e5 - 2.0e8
<i>Escherichia</i> spp.	2.58e8 	3.7e6 - 3.8e9
<i>Lactobacillus</i> spp.	3.31e7 	8.6e5 - 6.2e8
<i>Enterobacter</i> spp.	2.32e7 	1.0e6 - 5.0e7
<i>Akkermansia muciniphila</i>	4.29e5 	1.0e1 - 8.2e6
<i>Faecalibacterium prausnitzii</i>	7.76e4 	1.0e3 - 5.0e8
<i>Roseburia</i> spp.	9.93e8 	5.0e7 - 2.0e10

OPPORTUNISTIC/OVERGROWTH MICROBES

DYSBIOTIC & OVERGROWTH BACTERIA

	Result	Reference
<i>Bacillus</i> spp.	2.41e6 High ↑	< 1.76e6
<i>Enterococcus faecalis</i>	<dl	< 1.00e4
<i>Enterococcus faecium</i>	7.70e2	< 1.00e4
<i>Morganella</i> spp.	<dl	< 1.00e3
<i>Pseudomonas</i> spp.	6.24e5 High ↑	< 1.00e4
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2.13e4 High ↑	< 5.00e2
<i>Staphylococcus</i> spp.	<dl	< 1.00e4
<i>Staphylococcus aureus</i>	2.28e3 High ↑	< 5.00e2
<i>Streptococcus</i> spp.	2.81e4 High ↑	< 1.00e3

COMMENSAL OVERGROWTH MICROBES

<i>Desulfovibrio</i> spp.	9.86e5	< 7.98e8
<i>Methanobacteriaceae</i> (family)	2.32e7	< 3.38e8

INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE-RELATED BACTERIA

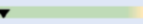
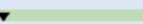
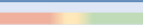
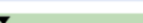
<i>Citrobacter</i> spp.	<dl	< 5.00e6
<i>Citrobacter freundii</i>	<dl	< 5.00e5
<i>Klebsiella</i> spp.	3.37e4 High ↑	< 5.00e3
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<dl	< 5.00e4
<i>M. avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>	<dl	< 5.00e3
<i>Proteus</i> spp.	<dl	< 5.00e4
<i>Proteus mirabilis</i>	<dl	< 1.00e3

COMMENSAL INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE-RELATED BACTERIA

<i>Enterobacter</i> spp.	2.32e7	< 5.00e7
<i>Escherichia</i> spp.	2.58e8	< 3.80e9
<i>Fusobacterium</i> spp.	5.22e8 High ↑	< 1.00e8
<i>Prevotella</i> spp.	2.35e6	< 1.00e8

FUNGI/YEAST

FUNGI/YEAST	Result	Reference
<i>Candida</i> spp.	1.02e4 High ↑	< 5.00e3
<i>Candida albicans</i>	5.69e2 High ↑	< 5.00e2
<i>Geotrichum</i> spp.	<dl	< 3.00e2
<i>Microsporidium</i> spp.	<dl	< 5.00e3
<i>Rhodotorula</i> spp.	<dl	< 1.00e3

INTESTINAL HEALTH MARKERS		
DIGESTION	Result	Reference
Steatocrit	<dl 	< 15 %
Elastase-1	151 L 	> 200 ug/g
GI MARKERS		
β-Glucuronidase	169 	< 2486 U/mL
Occult Blood - FIT	<dl 	< 10 ug/g
IMMUNE RESPONSE		
Secretory IgA	1260 	510 - 2010 ug/g
Anti-gliadin IgA	27 	< 175 U/L
Eosinophil Activation Protein (EDN, EPX)	0.61 	< 2.34 ug/g
INFLAMMATION		
Calprotectin	<dl 	< 173 ug/g

- Résultats GI MAP (test de selle) :

- **HBP (Helicobacter Pylori)** => présence en quantité modérée => réduction d'acide gastrique => sous- absorption des nutriments => porte ouverte à tous les microorganismes
- **Bonnes bactéries** => équilibre
- **Dysbiose** – mauvaises bactéries => fonction digestive réduite, selles molles, crampes intestinales, gaz, inflammation...
- **Candida Albican**
- **Marqueurs digestifs** => **Elastase-1 = faible** => mauvaise digestion/absorption à cause d'une production enzymatique insuffisante (à cause peut- être d'HBP)

→ Avant de lui proposer un accompagnement, je le **renvoi vers son médecin avec les résultats**.

→ **Résultats sérologie HBP** = négative

Consultation de suivi 2 - François - Juin 2023

- Suivi 2 – François :

Alimentation :

- Eviter les aliments qui alimente le candida albican (voir cours sur le candida albican) :
 - Bannir les sucres raffinés
 - Les produits laitiers
 - Les levures
 - Les céréales blanches

Axes à travailler, en lien avec les symptômes :

- **Sous-absorption & carences**

→ Via H.Pylori, pancréas (Elastase-1),
microbiote/dysbiose, candida

- **Inflammation chronique**

→ Via enzymes pancréatiques (Elastase-1),
microbiote/dysbiose, candida

Prioriser

- **Présence d'Helicobacter Pylori** => moins d'acidité gastrique (point d'entrée de la digestion) => rétablir l'équilibre
- **Booster les enzymes**
- **Rééquilibrer le microbiote**
- **Déséquilibre de fond** => candidose

Accompagnement spécifique :

Mois 1 (juillet 2023) = Protocole Helicobacter Pylori

→ **Mastic Gum**

1 capsule avant le déjeuner et le dîner – 6 semaines

→ **Lactobacillus reuteri**

2 capsules le matin à jeun – 6 semaines

- Mois 2 (août 2023) :

→ **Finir cure Mastic Gum**

→ **Finir cure Lactobacillus reuteri**

→ **Soutien enzymes pancréas**

1 capsule avant dej et dîner

→ **Cure de probiotiques**

1 capsule avant manger matin et soir

→ **Bétaine HCL**

1 gel avant dej et dîner

>>> Alimentation anti-candida

- Mois 3 (septembre 2023) :

- poursuivre la **cure de probiotiques**
- poursuivre la **Bétaine HCL**
- poursuivre les **enzymes (pancréas)**

>>> Alimentation anti-candida

- Mois 4 (octobre 2023) :

- **attaque la candidose** normalement déjà affaibli par le régime alimentaire.
- voir si on commence à **renforcer la barrière intestinale : Zinc, carnosine, vit A, L-Glutamine & peut-être intégrer des prébiotiques** : inuline par exemple (via alimentation)

Consultation de suivi 3 - François - décembre 2023 :

- Suivi 3 - François :

Améliorations :

- Plus **aucune diarrhée** sauf si excès d'alcool et de gras
- Aucun **ballonnement**
- A la sensation de pouvoir tout manger
- **Meilleure énergie**

Difficultés :

- La **mastication**
- , **Manger en pleine conscience**
- Quand il fait beaucoup de sport => **crampes intestinales et envies urgentes (selles moulées)**
- Régime anti-candida : **n'a pas vraiment suivi**
- **Beaucoup de stress**

Axes à travailler :

- **Ne présente plus de signes de candidose**
- **La gestion du stress** => l'orienter vers un sophrologue

- **Renforcer sa barrière intestinale** pour optimiser son microbiote, son absorption et ses fonctions immunitaires

Alimentation :

- **Alimentation équilibrée et variée, de saison, des produits bruts, chrononutrition**
- **Augmenter ses protéines** car il fait beaucoup de sport
- Adapter son alimentation quand c'est une journée avec du sport : **plus de féculents, protéines, une boisson maison avec des électrolytes** (eau de coco, une dose d'électrolytes, ½ orange pressée ou des fruits rouges)
- Effort sur **son hydratation**
- **Alimentation pré/probiotiques :**
 - Fibres : inuline (poireaux, ail, topinambour, oignons)
 - Choucroute, kimchi, tofu lactofermenté, miso, tempeh
 - Kombucha, kéfir avec modération au début (observer l'impact sur la digestion)

Accompagnement spécifique :

- **L-glutamine** (Nutripure) : 1 dose par jour (soit 5g) – 3mois
- **Magnésium** : 1 matin/midi/soir – cure tous les 2 mois ou en continue avec une pause de 7 jours.
- **Vitamine D/K2** : prise de sang – toute l'année sauf si exposition au soleil
 - Objectif : 45/60 ng/ml de vitamine D
 - Adapter la posologie en fonction de son taux

VI- Conclusion :

- Conclusion

- Pour l'instant **pas de moyen de diagnostiquer** un Covid long
- Beaucoup de **symptômes peuvent faire penser à un Covid long**
- Certains consultants énumèrent des symptômes sans évoquer un « Covid long » => **importance de poser les bonnes questions** « avez-vous eu le Covid ? Quand ? Difficulté ? Symptômes ? Accompagnement ? »
- Accompagner **au cas par cas en fonction des symptômes**
- Si vous pensez à un Covid long, **parlez-en avec votre médecin**